

목차

교과서 기준

1단원 월경과 관련된 질환 [주로 호르몬 관련]

1장	무월경과 비정상 자궁출혈	① 무월경 ★★ + PCOS ★★ ② 비정상 자궁출혈 ③ 월경부조 ④ 월경선기 ★ ⑤ 월경후기 ★	⑥ 월경선후무정기 ★ ⑦ 월경과소 중요X ⑧ 월경과다 ★ ⑨ 경기연장 중요X ⑩ 경간기출혈 중요X ⑪ 봉루 ★★
2장	월경통과 골반통	① 월경곤란증 ★★ + 자궁내막증식증 ★★, 자궁선근증	
3장	월경전증후군과 기타장애	① 월경전증후군 ★ ② 경행병과 월경전증후군	

3단원 대하 및 기타 생식기 질환 [주로 감염 관련]

1장	대하 ★★	① 개술 ② 유발 부위 ③ 한의 외래진료
2장	기타 생식기 증 후와 질환	① 음통 ★ ③ 음양 중요X ② 음창 중요X ④ 음냉 중요X
3장	성전파성 감염 STI 중요X	① 개요 ② 박테리아성 성 전파성 감염 ③ 바이러스성 성 전파성 감염 ④ 원충 및 기생충 성 전파성 감염 ⑤ 성 전파성 감염과 HIV ⑥ 임신부 감염시 태아 및 신생아에게 미치는 영향 ⑦ 성전파성 감염과 모유수유 ⑧ 한의학적 치료
4장	골반염증성 질환	① 골반염증성질환★ ② 만성 골반염증성 질환

※ [참고] 치방의 약재 용량 문제

- 구체적인 약재 용량을 꼭 정확하게 암기해 작성할 필요는 없다고 합니다.
- 약재의 구성과 군신좌사의 구분이 더 중요하다고 18, 19때 말씀하셨다고 합니다.

9주차

1단원 월경과 관련된 질환

1장 무월경과 비정상 자궁출혈

1절 무월경

1. 개술

★ 원발성/속발성 무월경을 정의하시오 04, 19

· 무월경: 원발성 무월경과 속발성 무월경으로 분류됨.

1) 원발성 무월경: 특별한 이상 없이 생기는 경우

2) 속발성 무월경: 다른 질환에 의하여 발생하는 경우

원발성 무월경	① 이차성징의 발현 없이 (유방 발달 등) 14세까지 초경이 없는 경우 ② 이차 성징의 발현은 있으나 16세까지 초경이 없는 경우
속발성 무월경	① 월경을 하던 여성이 6개월 이상 월경이 없는 경우 ② 평소 월경 주기의 3배 이상의 기간동안 월경이 없는 경우 : 그렇다면 3개월만 없어도 무월경? (X) 45일 주기인 경우도 있기 때문
한의학의 무월경	- 경폐, 여자불경, 월사불래, 경수단절 - 무월경의 변증: 虛, 寒, 瘀, 痰飲 → 무월경은 허증(간 신 비), 한증, 어혈(기체혈어), 담음으로 분류됨 (복합적으로 발생) → 변증을 구체적으로 할수록 치방이 쉬워지므로 변증시치가 중요함. → 변증을 %를 활용하여 디테일하게 할 필요가 있음. 예 허증 70%, 한증 10%, 어혈 20%로 나타나는 경우 이럴 경우, 먼저 허증을 장부(신간비) 중 어디에 배속시켜야 하는지 따져서 기본방을 정함. 신허라면 신기환이 기본방(君)이 되며, 여기에 한증 10%과 어혈 20%를 치료할 수 있는 약을 臣, 佐로 더하는 것이 후세방 사용방법.

2. 병인 병기

★ 무월경 월경의 원인을 허와 실로 나누시오 03

허	① 간신부족 肝腎不足	- 간신이 부족해지면 월경을 생성하는 기능이 떨어지게 됨 → 신은 월경의 선천적 근본, 간은 월경의 양을 결정함.
	② 기혈허약 氣血虛弱 (비기허)	- 선천적 비위기능 허약, 불규칙하고 부적절한 식생활, 다이어트 - 지나친 사려/노동, 대량의 출혈, 만성질환 → 월경의 후천적 근본이 적어지는 것 → 최근 무리한 다이어트로 인한 문제가 흔히 생김. (에스트로겐의 근본은 콜레스테롤이므로 너무 마르면 무월경)
	③ 음허혈조 陰虛血燥	- 평소 음이 허한 체질 - 실혈로 음이 휴손된 경우 - 오랜 질환으로 영혈이 휴손된 경우
실	④ 기체혈어 氣滯血瘀 (칠정상)	- 칠정으로 내상을 입으면 기가 울결되고, 혈이 응체되어 무월경 - 정신적 요인과 관련 예 신경을 많이 쓰거나, 갑작스러운 정신적 충격 이후 나타나는 월경
	⑤ 담습조체 痰濕阻滯	- 비만하여 담습이 많은 경우 예 PCOS의 병리 (논문에 따르면 우리나라는 마른형 PCOS가 많다는 연구결과도 있어 꼭 변증을 따르지는 않을 수 있음을 시사함.)

3. 무월경의 병인학적 분류

- 무월경은 **HPO 축의 이상**을 초래하는 원인에 의한 하나의 증상
- HPO축의 이상은 각 기관 자체의 이상에 기인할 뿐만 아니라 기타 내분비학적 질환 및 비내분비학적 질환에 의해서도 발생.
- 그밖에 **월경유출로(outflow tract)의 구조적 이상**이 있는 경우에도 무월경이 발생.
 예) 처녀막 폐쇄로 월경혈이 나오지 못해서 절개해줬더니 해결됨.

- 초래하는 원인 질환에 따라 다음과 같이 분류

1) 중추신경계 요소	(중추) 신경성	기질성 뇌질환, 시상하부 결함/장애, 의인성
	뇌하수체 장애	손상, 종양, 선/후천적 결함
	정신적 인자	
2) 중간적 요소	영양성 무월경, 만성질환, 내분비 장	
3) 생식선 요소	선천적 결함, 조기폐경, 종양, 불감성 난소증후군	
4) 말초기관 요인	부분 자궁절제술, 자궁강 경화, 자궁경관 협착	
5) 생리적 요인	폐경, 임신, 수유	

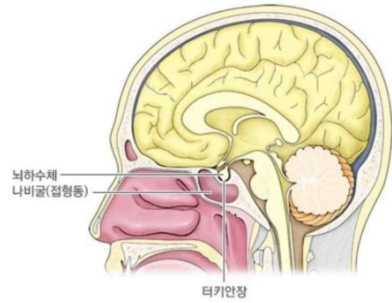
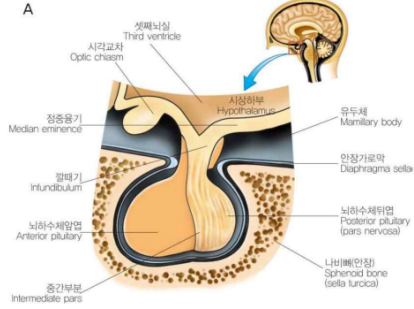
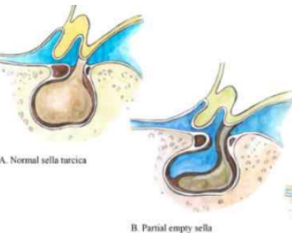
1) 중추신경계 요소

(1) (중추) 신경성

기질성 뇌질환	손상, 종양		
	감염성질환, 독소		
시상하부 결함	GnRH 결핍		
	<u>Kallmann's syndrome</u> (칼만 증후군)	① X염색체 열성 질환 : 선천적인 KAL-1 유전자 이상으로 인해 GnRH 결손 유발 → 성선 자극 못함 → gonadotropin 현저히 적음 - 염색체 수의 문제가 아니라 염색체 자체의 유전자 이상이 원인이 되어 gonadotropin의 분비가 낮아져 생기는 증후군 ② 발생 비율은 남녀 5:1로 남성에게 ↑ - 남성 : 왜소성기증, 성욕 감퇴, 발기부전, 근력 약화, 고환 용적 감소 (칼만증후군 남성은 고환 용적이 4ml 이하 / 정상 성인은 20ml) - 여성 : 무월경, 불임, 유방 발달 감소 ③ 특징 : <u>무후각증</u> , 구개열(토순) - 발생학적으로 GnRH와 후각을 담당하는 세포가 같은 곳에서 기원하기 때문에 GnRH 이상을 나타내는 칼만 증후군에서는 후각 이상이 동반됨	
시상하부 장애	영양성 무월경	① 단순한 체중 감소	콜레스테롤 부족하면 에스트라디올 안나오니까 무월경
		② 약물복용 후의 저체중	
		③ 비만	E1의 상승에 의한 E1-E2 역전현상으로 인해 무월경이 발생, 비만은 PCOS랑도 연관
	운동과 관련된 무월경	★ 과격한 운동이 무월경을 발생시키는 과정의 호르몬 변화 서술 19 ① 황체기 결함과 관련됨. ② 운동선수급에 해당  태릉선수촌 여성선수 - 과격한 운동으로 GnRH의 분비 주기가 길어짐 → 황체호르몬의 분비주기가 길어짐 → 황체기 결함이 발생 *배란의 조건인 에스트로겐 200pg/50시간 이상을 만족하는 시기가 늦어지기 때문에 황체기 결함이 발생함.	
	스트레스로 유발된 무월경	★ 스트레스가 무월경을 일으키는 과정에서 호르몬 변화 서술 19 - 스트레스로 인해 시상하부에서 CRH 증가 → 내인성 opiate 증가 → GnRH 억제 (내인성 opiate는 GnRH와 길항작용을 하기 때문) - 한 번의 대량의 스트레스보다는, 장기간 반복되어 누적된 스트레스로 인한	
	되먹이기 기전의 장애	① <u>다낭성난소 증후군(PCOS)</u> ★★★ 무월경의 80% 정도는 PCOS라는 생각이 들 정도로 많으며 중요한 질환 [뒤에 자세한 내용 나옴]	
② 부신성 안드로겐 생성			
③ 비만			
의원성 무월경	약물		

(2) 뇌하수체 장애

뇌하수체의 많은 부분이 파괴돼야 비로소 증상이 발생함. $GH \rightarrow Gn \rightarrow TSH \rightarrow ACTH$ 순으로 타격받음. (생명이 위급하지 않은 것부터 점점 생명과 직결된 TSH, ACTH 순서대로 타격을 받음)

손상	쉬한 증후군 (Sheehan's syndrome)	★ Sheehan's syndrome 원인 설명 19 - 출산 시 과다출혈로 인한 저혈량 쇼크로, 뇌하수체의 허혈성 괴사로 무월경 발생 - Simmon's syndrome의 유발요인 중 하나 / 요즘은 다 산부인과 가서 출산하기 때문에 드물
	Simmond's syndrome (범뇌하수체 기능저하증, panhypopituitarism)	- 범뇌하수체 기능저하증: 뇌하수체 절제, 비분비성 뇌하수체 종양, 성호르몬 분비 결함, 쉬한증후군, 기능성 영양장애 등으로 인한 - 왜소발육, 생식선위축, 유방축소, 갑상샘, 부갑상샘 기능 위축, 전반적인 대사, 영양, 혈당, 면역 장애 등
종양	비기능성 종양	*
	기능성 고프로락틴혈증 무월경	- 뇌하수체 선종이 가장 큰 문제 - PRL 100 이상 (정상: 5~25mg/mL) → 임신과 관련없이 프로락틴 분비가 지나치게 높아지는 경우
선/후천적 결함	공터키안 (empty sella)	- 안장가로막이 선천적으로 없는 사람 - 실제 임상에서, 정상 뇌하수체는 터키안에 위치하며, 지주막과 안장가로막으로 받쳐지는데, 압력에 의해 뇌하수체가 아래 지주막 쪽으로 떨어져 내려가서 생기는 경우가 많음. - 뇌척수액이 많아져, 뇌하수체를 내리누르는 경우도 있음. - 여성 환자가 80%이며, 별다른 증상은 없음 - 혈압, 비만, 고지혈증 경향성만 조금 높아짐, 간혹 무월경과 관련.    
	부분적으로 격리된 생선샘자극 호르몬 결핍	*

(3) 정신적 인자

① 급작스러운 정서 장애

② 신경성 식욕부진

③ 상상 임신 배가 나오고 유즙이 나오기도 함. 정신적 문제를 가진 경우가 많음. 임신이 절박했기 때문에 발생하는 경향. (강형원 교수님한테 보내라)

2) 중간적 요소

영양성 무월경	비만		
	기아, 영양실조		
만성질환	결핵 등으로 인한 난소 기능 저하		
내분비 장애	갑상선 기능 저하증		갑상선 기능 항진증에서 폐경으로 이행되는 것과 같은 증상이 나타나기도 함. 월경이 느려지다가 없어짐.
	갑상선 기능 항진증		저하증에서는 월경후기 대사가 기능이 떨어짐. 월경이 빨라지다가 없어짐.
	부신기능 저하/항진증	선천성 부신 과형성	
		Cushing's syndrome	- 원인: 약물, 질환 등 어떤 원인으로 ACTH가 상승해 코티졸 과잉 / 스테로이드 약물 부작용 - 증상: moon face , 피부 얇아짐, 상처 잘 안 나음, 혈관이 약해져서 쉽게 멍듦, 고혈압/심장 질환의 원인이 됨, 거북이 등 , 근육 약해서 사지와 손가락은 가늘어지는데 배는 점차 불러나오는 중심성 비만 이 생김
		Addison's disease	- 부신피질기능부전증 (ACTH 감소), 미국 존F.케네디 전 대통령이 앓던 질환으로 유명 - 원인: 75%는 자가면역질환 일 것으로 추정 → 21OH효소, 특이항체의 자가면역반응으로 부신이 파괴되어 발생 / 결핵 매독 종양 등이 부신으로 전이되어 부신이 파괴 - 증상: 전신의 심한 피로 , 빈혈, 저혈압, 저혈당, 전반적 기초대사 감소, 피부나 구강에 갈색색소 침착 , 각종 소화기 질환 (식욕부진, 복통, 설사) - 부신피질이 90% 정도가 파괴되어야 증상이 발현된다고 함.
	고프로락틴혈증		
	당뇨병		
대사성 질환	신질환, 간질환		

3) 생식선 요소 (간단히만 언급)

선천적 결함	생식샘 기형	
	중성, 1자웅동체	
	섞임증(Mosaicism) 예) 터너증후군	
² 조기폐경 (조기난소부전증)	자가면역성	
	염색체성	
	Destructive	의원성 : 외과적, 약물
		방사선 조사(irradiation)
		바이러스 질환
		신생 (Neoplasia)
	체질적 (Constitutional)	
손상		
불감성 난소증후군	난소 자체에 FSH 수용체가 없는 경우 (FSH receptor의 결함)	
종양	기능성 종양	
	비기능성 종양	

1) 자웅동체 : hermaphroditism, 남녀생식기 모두를 가짐

2) 조기폐경: 대부분 원인미상이나, 유전성(가족력)에 의한 것으로 추정함.

[참고] 환자 CASE

무월경으로 온 환자와 어머니. 처음에 PCOS를 의심하였으나 FSH 수치가 100이 넘게 나옴. (FSH 수치가 높으면 PCOS는 아님.) 진단한 의사가 폐경이니 아이를 가질 수 없다는 소견을 내서 어머니와 의사가 크게 싸움. 그러나 교수님께서 임신에 초점을 맞춰서 치료 시도를 해보고자 하였고 현재 아이가 두명! 당시에 조경종옥탕 사용. AMH가 거의 0에 수렴했어서 호르몬제를 사용하고 한의학적 치료를 부가적으로 시행했던 환자.

4) 말초기관 요인 End organ cause

★ Asherman's syndrome 원인 설명 19

부분 자궁 절제술		
자궁강의 경화	Asherman's syndrome	D&C: 자궁소파술
		자궁경부원추절제술
		자궁경부전기소작술
		심한 골반염증성질환
		IUD자궁내 피임장치로 인한 만성적 감염
자궁경관 협착	원추절제후	

- Asherman's syndrome은 쉬한증후군과 달리 최근에도 꽤 있음.

5) 생리적 요인

생리적으로 월경이 오지 않는 경우는 다음 3가지 경우에 해당

- ① 폐경
- ② 임신
- ③ 수유

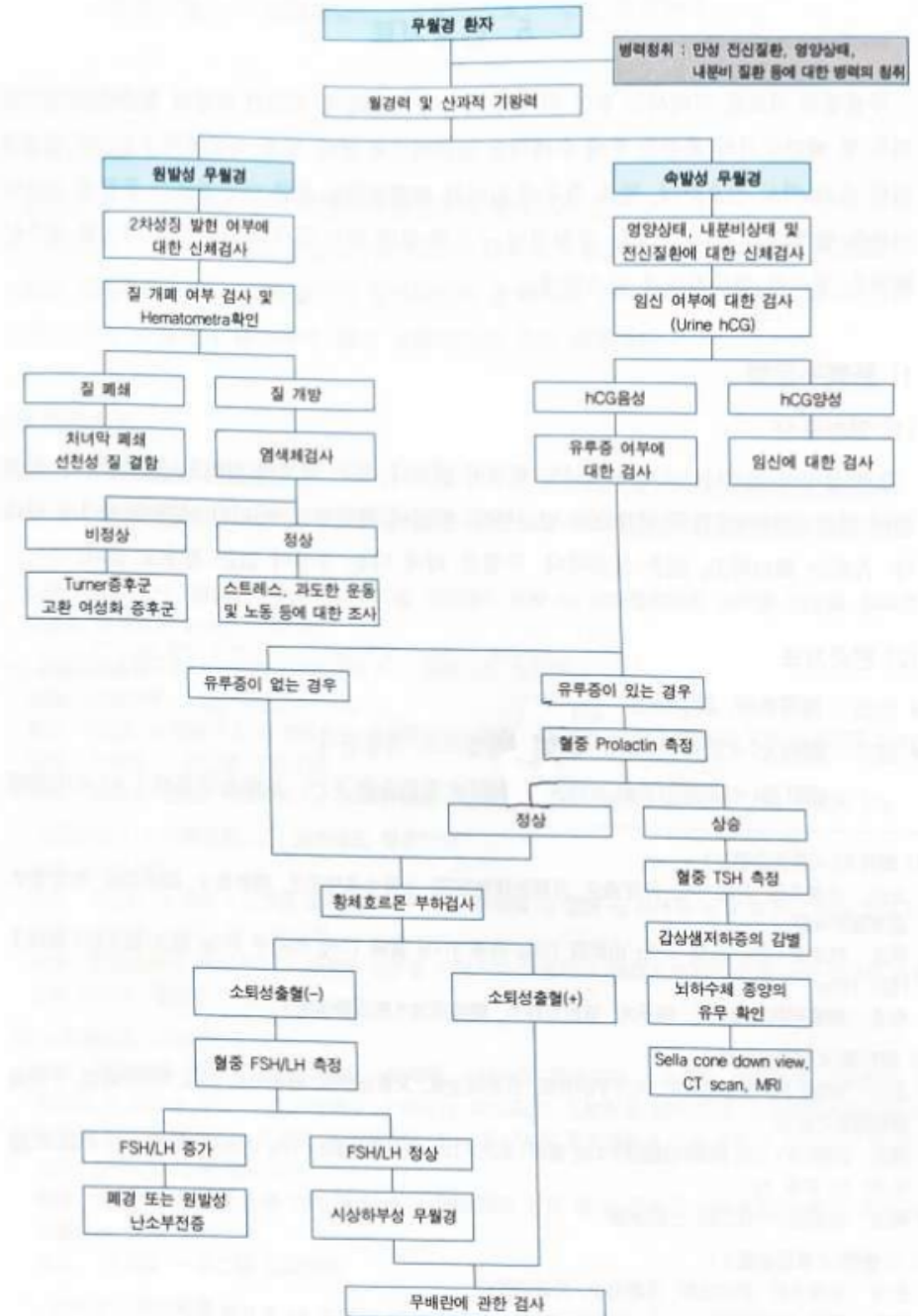
4. 진단

병력청취	- 성장발육의 기왕력 - 월경력 및 산과적 기왕력 - 스트레스 및 정신적 이상 - 전신질환 및 신체적 이상과 관련된 증상 등 - 자세히 문진		
신체검사 이학적검진	- 이차성징에 대한 평가 - 요로증/골반질환 여부, 외음부 기형 여부 확인		
특수검사 [강조★]	★ 가장 중요한 것은 β -hCG : 임신 여부를 판단하는 검사		
	목적성 진단	FSH, LH, E2, T, ADD	
	배제 진단	β -hCG	임신 가능성 배제
		PRL	고프로락틴혈증 배제
		TSH	갑상선기능이상 배제
CBC(일반 혈액검사)		빈혈가능성 배제	

- 빨간 네모: 루틴 검사(필수 진단검사)
- + LFT/RFT 신장검사도 미리 하는 경우 많음.
- + 희발월경이나 무월경 기간에 따라 자궁내막의 두께를 꼭 재오도록 함.
16mm가 넘으면 생리 주사를 맞은 뒤 주기조절을 시작해야 함.
- + AMH는 예후인자로 쓰고 필수인자로 보지는 않음.

※[참고] 우측 그림 진단표

- 속발성 무월경 : 유루증이 있는데 프로락틴이 정상일 경우는 별로 없음
- 황체호르몬 부하검사는 E가 분비되고 있는지 확인하기 위함
- 모든 가임기 여성 검사에서는 반드시 '임신가능성'을 확인해야 함.
→ 따라서 LMP를 물어보고 hCG 확인하는 것이 가장 중요하다.



5. 변증치료 ★★★★★

변증	임상증상	치법	처방
간신부족 '17	- 2차 성징이 늦은 경우 / 15세가 지나도 월경이 없는 경우 / 월경이 있어도 불규칙한 경우 - 월경량이 점차 적어지다가 무월경으로 발전 - 체질허약, 허리와 무릎이 시리고 약함(요슬산연) / 무월경 외에 다른 증상이 없는 경우도 있음 - 설태박백, 맥침약 → 교수님께서 아직도 애매한 부분이 있고 도움이 안되므로 수업하지 않겠다고 하심.	보신양간 조리충임	¹ 귀신환 조간탕 ² 소영전가감
기혈허약 '17	- 월경이 점차 지연되고 양이 적어지며 월경색이 열어지고 질은 묽어지는 등의 증상이 있다가 무월경 - 어지럽고 눈앞이 아른거리며 안색이 누렇고 두근거리며 숨이 가쁘고 피로하며 식욕부진하고, 모발에 윤기가 없어지 면서 잘 빠지는 등의 증상 (두훈안화, 면색위황, 심계기단, 핏로, 식욕부진, 모발무화/탈락) - 설담 태소/박백 맥침완/허삭	보기량혈 조리충임	³ 인삼양영탕 ⁴ 성유탕 팔물탕
음허혈조 '17	- 월경량이 적어지고 늦어지다 없어지거나 찔끔 있으면서 끊어지지 않으며, 주기를 잃기도 함 - 월경색은 어두운 자색이고 질은 끈끈함 (열증이 있으면 질이 점조/끈끈한 경향) - 조열/오심변열/인건설조 증상 (=갱년기/만성소모성 질환 증상) + 심하면 도한골증, 현저한 체중 감소, 해수/객혈 - 설홍, 태소, 맥세삭	자음익정 양혈조충	⁵ 가감일음전 ⁶ 옥녀전
★★★★ 기체혈어 '05,11,12, 14,17	- 갑자기 무월경이 됨. (칠정상, 간울기체로 인한 혈어의 상태) - 우울하거나 감정표현이 억압되어 있고, 가슴이 답답하며 화를 잘냄 (정신억울, 번조이노) ★정신증상 - 가슴과 옆구리가 그득하며, 아랫배가 부르면서 아프고 만지면 거북함. (홍협창만, 소복창통) - 설암, 어반, 태는 정상/미황, 맥현/긴	활혈화어 조리충임	혈부축어탕 ★격하축어탕 소복축어탕 ⁷ 개울이진탕(만씨부인) ⁸ 통경탕 ⁹ 가감귀비탕 (자침) 기충, 지기
담습조체 '13,17	- 비만한 체격으로 특히 양쪽 팔, 허리, 둔부 등의 비만이 심함 (전형적인 인슐린저항성 있는 PCOS 증상) - 월경량은 차츰 감소하고 월경주기도 늦어지면서 무월경이 됨 - 체중은 증가되는 추세이고 피곤하거나 권태감을 느끼고 식욕이 없거나 부종이 잘 나타남 (똥똥+잘 붓고+게으름) - 가슴과 옆구리가 그득하고 답답하거나 대하량 ↑ - 설담비눈 태백니 진액많음 맥침활	활담제습 감비소지 온운활혈 조리충임	창부도담환 ¹⁰ 개울이진탕(섭천사) (자침) 풍릉, 음릉천

① 귀신환 : from 경약전서 부인규 / 신기평보 / 양허하면 우귀음, 음허하면 좌귀음

육미에서 去 택사 목단피 加 당귀 구기자 토사자 두충

② 소영전 : from 경약전서 / 당귀 속지황 작약 산약 구기자 자감초

③ 인삼양영탕 : from 화제국방 / 김강산 교수님 최애 처방 / 모든 피로에 의한 모든 증상에 적용 (허중에 사용하는 약제는 다 들어가 있음) 동의보감에서 방풍이라고 나오는데 사실상 원전은 복령으로 되어 있음. 처방 구성으로 교과서에 기재된 방풍은 오류이고 방풍 대신 복령을 넣는 것이 옳다고 추정됨. (마르거나 허한 노인에게는 방풍, 복령 둘다 넣기도 함.)

④ 성유탕 : 허열 때문에 음액이 모손된 경우

⑤ 가감일음전: 간신음허로 인해서 열에 의해 음액이 모손되어 월경과소

구성: 일음전(생지황 숙지황 작약 맥문동 당초 우슬 단삼) 去 우슬 단삼 加 지모 지골피 보음전과 비교하면, 보음전이 더 열을 치는 처방, 일음전은 자음 + 허열을 봐주는 처방

⑥ 옥녀전: 석고&숙지황이 군약, 위열치성이라는 정황이 있는 음허에 활용

⑦ 개울이진탕 : from 만씨부인과, 이진탕류라서 치담작용이 있으므로 담습조체에 분류되는 것이 더 적절하다고 봄.

⑧ 通경탕 : 무월경에 활용 / 痛경탕 : 월경통에 활용 (지금 나오는 통경탕은 전자)

⑨ 가감귀비탕 : from 청강의감

⑩ 섭천사의 개울이진탕에는 반하/진피/복령이 없으므로 만씨부인과의 ⁷개울이진탕을 추천함.

★ 부인과 기체혈어 질환에 사용하는 격하축어탕, 혈부축어탕, 소복축어탕의 효능과 적용범위를 비교 (13, 18)

※ *왕청임의 의림개착에 나오는 축어탕 삼총사 : 각각 三焦에 들어감 [★축어탕 비교 중요]

처방	타깃	효능	구성 (밑줄만 언급)	비고
혈부축어탕	상초 홍격부	활혈거어 청열량혈	도인 홍화 당귀 생지황 천궁 적작약 우슬 길경 시호 지각 감초	열에 의해 혈의 모순과 정체가 일어나 상초에 문제를 일으키는데(기체, 울화, 상염) 이기활혈 시키면서 생지황, 시호 등의 차가운 약으로 청열량혈 하고 하기시키는 우슬을 통해 살살 달래서 내려보냄 예 고혈압성 뇌증, 관상동맥질환 (협심증)
격하축어탕	중초 상복부 (간담, 비위)	활혈화어 이기해울	오령지 당귀 천궁 도인 목단피 적작약 현호색 감초 홍화 향부자 오약 지각 (이기)	기기를 뚫어 활혈거어 즉, 기를 뚫어서 혈을 움직이게 만드는 것
소복축어탕	하초 어혈성 부인과 질환	활혈거어 온경 지통	소회향 건강 육계 (온경) 포항 오령지 당귀 천궁 적작약 현호색 몰약 (지통)	여성의 소복은 차가워지기 쉽기 때문에 따뜻해줘야 함. (따뜻하면 기가 움직이게 되어있음) 활혈거어하는 약에 ① 온경약 을 넣어 기기를 움직여 활혈화어 작용 강화 ② 지통약 을 넣어 온경지통함 → 따라서 한응성 월경통에 대응

*격하/소복축어탕은 혈의 순환이 잘 되어야하는 가임기 여성에게 특히 활용도가 높음.

*도홍사물탕을 베이스로하여 혈부축어탕, 격하축어탕이 만들어졌는데 소복축어탕은 도홍사물탕을 베이스로 하지 않았음. 소복축어탕은 통증에 대응하기 위한 몰약, 따뜻한 약을 많이 사용함.

※ 왕청임 소개

- 왕청임은 **활혈거어지제**를 매우 잘 사용한 인물 → 축어탕 삼총사 외에 신통축어탕/ 통규활혈탕과 같은 처방 등을 소개했음. (특히 신통축어탕은 강활 등이 들어가서 사지말단에도 들어감)
- 왕청임은 해부학자를 자칭하여, 시체안치소에 살다시피하였으며 죄수들 사형시키면 꼭 가서 해부했다고 함.

※혈부축어탕 보충 설명

- 혈부축어탕의 활용 : 가슴속에 어체가 있어 가슴이 답답할 때
- 혈부(血府)의 의미 : 2개의 관점이 존재 (①이 유력)

- ① **心を 상초에 대응**: 왕청임은 胸任重物(흉임중물)이라 하며, **혈부를 心(심장)이라 보고 상초에 대응**하였음. 왕청임이 시체 해부했을 때 심장의 피가 다 빠져나가서 아무것도 안 들어있었기 때문에 府라고 명명했다는 관점. (간은 해부하니 실질이 가득차있어 혈이 들어갈 곳이 없어 간장혈이 아니라고 생각했고 심장은 비어있었기 때문)
- ② **간울이 오래되어 化火→生風→간풍내동한 상황에 응용**: 고전에 '혈의 장부=간'이라고 기재되어 있는데, 간의 병리(간울화화&열극생풍)의 병리를 치료하는 약물이 차가운 약물인 **생지황, 우슬, 시호**임. 이때 풍은 뇌질환(중풍)과 연관이 있으며, 머리는 두개골로 막혀있어서 어혈이 발생하면 갈 곳이 없고, 원래 열이 몰리는 곳이기도 하기 때문에 다독다독 식혀서 내려줘야함. 그래서 청열량혈하는 약물을 쓰고, **우슬**로 하기하는(내려주는)것이라는 관점. (실제로 혈부축어탕은 초기 뇌출혈에 다용함)

다낭성 난소 증후군 PCOS ★★★ p.195

✓ 교과서 정의

- 원인 ① 신경내분비적 분비조절기능 이상 ② 비만

다낭성난소증후군은 시상하부, 뇌하수체, 난소 및 부신 등의 다양한 기관의 기능적 교란에 의하여 무배란증, 조모증, 불임증 등의 다양한 임상 증상을 초래하는 내분비계/대사계의 이질적인 복합체로서 만성적인 무배란 및 고안드로겐혈증에 의한 다양한 임상 양상을 보이는 증후군

1) 증상

- 난소 기능 x → 희발월경, 만성무배란
- 고안드로겐혈증
- 비만 (지방세포와 E1이 많아지고, 인슐린 저항성이 높아짐, 비만은 원인이자 증상)

2) 진단 기준 ★★★ p.201

★ 다낭성 난소 증후군의 진단 기준을 기하시오. '18

★ 다낭성 난소 증후군의 진단기준과 임상적 진단과정을 쓰시오 '15

★ 다낭성난소증후군의 특징적인 호르몬 변화에 대해 기하시오 '03, 10

★ PCOS의 중요한 3가지 병리 및 그와 관련된 임상증상을 기하시오 '09

★ 다낭성 난소 증후군은 () 과 ()이 있으면 다낭성 난소 증후군으로 간주할 수 있다. '08
희발배란, 희발월경 / 고안드로겐혈증 / 초음파상 다낭성소견

- 표준적 진단을 위해 1990년 NIH, 2003년 Rotterdam(로테르담), 2006년 AES(안드로겐학회)의 진단기준이 제시됨. 그 중 현재 주로 사용하는 것은 로테르담의 기준

[강조★]

※ 로테르담 기준 : 아래 3가지 중 2가지 이상 만족 시 PCOS로 진단

- ① 희발배란/희발월경 ② 고안드로겐 혈증 ③ 초음파상 다낭성 소견

희발배란 /희발월경	- 희발월경, 무월경, 기능성 자궁출혈, 불임을 유발 → 혈액 검사 시 보통 호르몬의 변화를 확인함	
	★ 호르몬의 변화 ✓ E2, (FSH), SHBG 감소 & LH, AMH 증가	
	E2 ↓	미성숙한 난포를 가져 E2가 잘 나오지 않음 특히, 비만인 사람은 E1 > E2 → 인슐린 저항성&대사증후군의 결과
	FSH 정상 or ↓	E2가 낮아서 FSH가 증가하려 하는데 이미 (동)난포가 있으므로 증가X
	LH ↑	LH : FSH = 2~3 : 1 LH는 배란을 시키려고 일을 하기 때문에 21~25 IU/mL이상으로 높아짐.
	SHBG ↓	비만으로 인한 인슐린 저항성이 간에 영향을 미쳐, 간에서 분비되는 SHBG(성결합 글로불린) 생성을 억제함
고안드로겐 혈증	AMH ↑	동난포에서 분비되는데, PCOS는 동난포가 많기 때문
	- 여드름/피지 증가, 조모증(털두껍), 다모증, 탈모증 유발 - 남성H 검사 : free-Testosterone, ADD(안드로스텐디온), DHEAs ↑ fT가 가장 중요. fT가 많이 높으면 고안드로겐혈증으로 추정하며, 이것을 확정하기 위해 ADD, DHEAs 둘 중 하나의 증가를 확인함	
초음파상 다낭성 소견	① 일측/양측 난소에 2-9mm 이하의 소난포가 13개 이상 존재 Pearl Necklace 양상 (진주 목걸이 두른 모양) → AFC (Antral Follicle Count, 동난포 개수를 세는 것) 시행 ② 난소의 크기가 정상(5*3*3)보다 1.5~2배 이상	



그림 4 다낭성 난소의 초음파 소견

3) 예후

- ① PCOS은 E 분비가 충분치 못한 상태임. (즉, 200pg/50h을 만족시키지 못해 배란X)
- ② E로 인해 자궁내막은 증식성 자극을 받는데, 배란이 되어 나오는 P가 나오지 않으므로 자궁내막이 견제없이 계속 증식함.
- ③ 이로 인해
 - 자궁내막이 너무 불균질해지면 기능성 자궁출혈 발생 (= E 파탄성 출혈)
 - 자궁내막이 계속 두꺼워지면 자궁내막증식증 발생 가능
 - 자궁내막 유착이 나타나면 기계적 불임의 원인이 될 수 있음
 - 원래 한달 뒤에 떨어지기로 약속한 세포인데 안 나가떨어지면 자궁내막세포의 이형성증, 심하면 자궁내막암이 발생할 수 있음.

[참고]

※ 暗經(암경): 배란을 하는데 월경을 안하는 경우 (월경을 하지 않음에도 생리기능에 이상이 없는 경우로, 월경없이 임신이 가능한 경우)

4) 양방

※ Yaz (야즈) 처방

[중간 수업 내용]

- 야즈는 4세대 경구피임약의 대표적인 약으로, 피임보다는 호르몬 안정성을 위해 다용
- 4세대 경구피임약의 성분 Drospirenone은 항안드로겐+이뇨작용
- 부작용 : 혈전 생성으로 인한 정맥혈전색전증 위험↑, 이 때문에 전문의 처방이 필요

장점	야즈는 <u>자궁내막암의 위험성을 줄이는 데 도움</u> 될 수 있음
단점	① 야즈는 자궁내막의 주기만 보고, <u>난소주기는 배제</u> 함 정상적인 E의 분비는 월경주기 그래프상 2번 반동해야 하는데, 야즈는 E를 낮은 레벨로 유지시켜 분비량을 일자로 만들. 이로써 자궁내막을 증식시키고, 때가 되면 탈락시켜 *출혈을 유발함. *이때의 출혈은 배란이 전제되지 않은 출혈이므로 월경에 해당하지 않음. (월경은 배란 14일 후의 출혈)
	② <u>배란이 안되는 PCOS 환자에게 배란을 못하게</u> 하는 약을 쓰는 격임 야즈는 피임약이므로 배란을 안 시키는 것이 목적이기 때문

5) 한방

- ① 장점 : 배란 주기의 항상성 회복 (일단 배란을 하면 14일 뒤에 월경을 하므로)
- ② 단점 : 언제 월경을 할 수 있을지 알 수 없음 (월경 시기를 가늠하기 위해 AMH 측정)
- ③ 응용 가능한 약물

향부자 당귀 대계 백질려	- 난포성장, 황체형성 도움 (특히, 향부자&당귀는 무월경의 대표약재)
감송향	- 전반적인 생식주기 회복 (생식주기 개시, 유지) - 감송향은 항안드로겐 작용이 있다는 보고가 있음. - 원래는 소화기계(비계)에 사용하는 약물임
반하 의이인 생강	- 담습조체 / 담습형 체형에 사용 - 특히 의이인의 활용도가 비만 환자의 경우 매우 높았음. - 의이인(울무)은 메토프로민(당뇨약)과 유사한 수준으로 인슐린 저항성 (대사 저항성)을 감소시키는 효과O
조갑자	- 정하편에 주로 등장 할 약재 - 천산갑과 함께 사용 시 자궁에 효과 (현재 천산갑 사용금지)

※ 대계 vs 백질려 vs 감송향

난포성장	대계 > 백질려 > 감송향
생식주기 개시/유지	감송향 > 백질려 > 대계

→ 환자의 변증에 따라 약물을 활용해야 함.

※ PCOS 환자의 내원 목적 : 비만 해결, 임신, 고안드로겐혈증 해결, 월경주기 회복

비만 해결	살을 먼저 빼야 함.
임신	치료 제일 용이한 편 → PCOS는 '절대불임요소'가 아니므로 임신 초반 유지만 잘해주면 예후 양호
고안드로겐혈증 해결 / 월경주기 회복	치료 어려운 편이라 치료 워딩 잘 안씀 (호르몬은 바로 반응하지 않으나, 환자는 즉각적인 호전을 원하므로) 희발월경은 "40일 주기 이내로 들어오도록 관리를 해봅시다."라고 안내

※ 난임과 AMH (항뮬러관 호르몬)

- 임상적 의의 : *난소기능 평가에 사용되며, 불임/난임 치료에 매우 중요함.
*앞으로 얼마나 배란할 수 있는지를 예측할 수 있는 지표, 난소 나이 측정을 의미
- 26.7세(가장 생식이 활발한 연령)에 5-6정도로 최고 수치를 보임.
- 35세를 기점으로 여성의 생식연령이 급격히 저하되며, AMH 수치도 감소함.
- AMH는 전동난포, 동난포에서 분비되는데, PCOS 환자는 전동/동난포가 많기 때문에 AMH가 높아짐. **예** 지금 교수님께 치료받고 있는 PCOS 환자의 AMH 수치가 15 : 생식능력이 높은 것이 아니라 PCOS로 비정상적으로 높아진 것 (교수님이 임상에서 본 최고 수치는 27, 예후가 좋지 않겠구나)
- AMH 측정 검사 비용은 높은 편이며, 난임/불임 판정을 받았을 땐 보험적용이 되지만, 그 외의 사유로는 보험적용을 받지 못함.

10주차

2절 비정상 자궁출혈 p.31

※ 무월경과 반대 질환이 아니라 무월경과 같이 올 수도 있고 증상 겹치는 경우 多

1. 개술

※ 용어 정리

① 비정상 자궁출혈 : 정상적인 월경의 양상을 벗어난 모든 출혈

② 기능성 자궁출혈

대부분 무배란성으로, HPO축의 문제로 인해 발생하는 이상 자궁출혈.

생식기의 구조적 병변 (=염증, 종양) 또는 이상임신에 의한 자궁출혈은 제외

+ 신경내분비계 질환, 외인성 스테로이드H의 영향, 갑상샘/간 기능 이상, 만성/대사성질환, 영양장애, 정신적 요인과의 관련

※ 추가 용어 정리

- 부정 자궁출혈 : 주기(定期)를 무시한 출혈 (즉, 때가 아닌 때에 나오는 출혈)

- 기질적 자궁출혈: 생식기의 구조적 병변 (염증, 종양), 이상 임신에 의한 자궁출혈

- 질 출혈 : 질의 열상/감염에 의한 것뿐만 아니라, 자궁출혈도 질을 통해서 나오기 때문에 자궁출혈까지 포함함.

※ 비정상 자궁출혈의 진단과 치료의 목적

① 즉각적인 출혈을 조절

② 더이상 유사한 자각증을 방지

※ 진료에 있어 기본적으로 검토되어야 할 3가짜 3가지로 되어있으나 5가지라고 말씀

① 출혈의 부위가 자궁인가? (아니면 질, 자궁경부 문제인가 등을 구분)

② 출혈이 배란성 월경 주기와 동반되는가?

③ 출혈이 무배란성인가?

④ 기질적 문제가 있는가?

⑤ ★ 그러나 가장 먼저 확인해야할 것은 임신 여부 (LMP 확인)

2. 정상월경의 특성

	범위	평균
초경 연령	9-17세	12.5세
월경주기	¹ 21-35일	28일
월경기간	3-7일	4.7일
월경량	² 30-80ml	35ml
폐경 연령	46-50세	49.7세

[참고]

① 월경주기가 21일이라면 배란을 7일 만에 해야 하므로 정상 아닐 가능성이 높음. FIGO 분류에서 정한 24-38일 주기가 실제 임상과 더 부합함.

② 월경량 30ml 이하라면 임신을 위한 최소 자궁내막 두께를 만족시키지 못하는 것임.

(임신을 위한 최소 자궁내막 두께 0.8cm 안정적으로는 1cm)

(월경 과소는 난임과 연관 있을 때만 치료함, 주로 월경과다가 문제됨)

3. 비정상 자궁 출혈의 형태

주기 이상	희발월경	월경주기 38(40)일 이상, 불규칙한 경우 (월경후기)
	빈발월경	월경주기 21(24)일 이하, 규칙적인 경우 (월경전기)
	월경선후무정기	월경 1달에 2번 / 2달에 1번
1유형 이상	월경과다	출혈 기간 8일 이상, 출혈량 80ml 이상 (시간적/양적인 면 모두 포함 / 0.8cm 의미)
	월경과소	주기는 규칙적이나 출혈량이 감소 (약 30ml보다 적은 경우 / 보통 치료를 요하지 않으나 임신과 관련된 문제시 치료가 필요)
무주기 출혈	부정자궁출혈	출혈이 주기와 무관하게 불규칙적 (월경선후무정기)
	과다 부정자궁출혈	빈번하고 규칙적 혹은 불규칙적인 간격이며, 대개 양이 과다하고 기간이 긴 출혈 (2붕루)
기타	3월경간 출혈	규칙적인 월경 주기와 주기 사이에 오며 대개 양이 많지 않은 출혈 (경간기 출혈) 에스트로겐 소퇴성 출혈에 해당
	3월경전 점상 출혈	정상 월경 며칠 전(2~3일)에 생기는 점상의 소량 출혈 프로게스테론이 급격하게 떨어지려하는데 프로게스테론이 완만하게 떨어지면서 발생하는 증상 200pg/50시간 곡선은 가파르게 나타나야하기 때문
	성교 후 출혈	자궁내막증에서 흔함. 자궁목염, 자궁목용종, 자궁목암 의심

1 유형 이상의 경우, 주기는 정상

2 붕루 = 붕중(출혈량이 갑자기+폭발적으로 많은 것) + 루하(출혈량은 적으나 기간이 길)

3 월경간 출혈, 월경전 점혈은 주소가 되지는 않고 변증의 근거 수준

- 희발월경, 월경과소 등은 단기적으로는 주소증으로 잘 내원X 부정자궁출혈은 주소증으로 흔함.

- 희발/빈발월경 주기는 보통 앞쪽으로는 3일, 뒤쪽으로는 2일 이상까지를 기준으로 함.

※ 비정상 자궁출혈의 FIGO 분류 (빈도와 기간 정도만 보면 된다 하시고 따로 언급은 X)

지표	정상	비정상
빈도	24-38일	빈발 (24일 미만)
		희발 (38일 초과)
		부재 (출혈X, 무월경)
기간	8일 이하	8일 초과

4. 비정상 자궁 출혈의 진단

★ 비정상자궁출혈에서 필요한 문진 및 고려해야 할 사항을 모두 기하시오 '11,13

① 출혈부위 판단 → 자궁인지, 자궁 이외의 하부생식기인지

(가임기 동안은 대부분 자궁내막성 출혈 / 자궁 외: 자궁경관, 질, 외음부, 요로 및 요도)

<감별> · 자궁경관: 자궁경부암성출혈 주의

· 요로 및 요도: 소변을 볼 때 출혈이 있는 경우 핏뇨, 빈뇨 등 요로계 증상이 있음.

② 출혈 원인 판단 → 기능성 / 기질성 (아래 표 참고, 대부분 기능성 자궁출혈에 해당)

기질적 자궁출혈이 아니라면 '기능성' 자궁출혈에 해당. 기능성의 경우, 배란도 잘 안되는 경우

③ 배란 여부에 대한 검토 : 배란이 있는가(기질적 질환), 무배란인가(기능적 질환)

★ 그러나 가장 먼저 확인해야할 것은 임신 여부 (LMP 확인)

자궁내막에서 유래하지 않은 출혈을 일으키는 기질적 인자		
자궁목 병변	종양(양성/악성), 1용종, 암, 외번증, 경관염, 2콘딜로마(congyloma)	
질 병변	암, 육종/선종, 열상 및 외상(유산 및 성교시), 감염, 이물질(폐서리, 탐폰의 장기사용), 유착, 위축성 염증	
다른 부위의 출혈	요로/요도	요도소구, 감염성 게실 (빈뇨, 찜찜 등 증상)
	위장관/직장	과민성 장 증후군 (변혈 등 증상도 출혈)
	외성기	음순 정맥류, 콘딜로마, 음순 외상, 염증, 종양 (양성/악성), 감염, 위축성 상태

1 자궁내막 방향으로 자라는 용종은 주의

2 콘딜로마: 침형콘딜로마는 출혈 잘 일으키지 않으며 HPV로 인해 생김, 편평형은 매독에서 발생

1) 문진

- ① 기왕 월경력 및 출혈양상: 출혈 간격, 기간, 양, **월경통**, 혈괴 또는 조직의 배출 유무 등에 유념 (혈괴: 질 쪽에서 나갈 때 울퉁 나가는 양상)
- ② 연령층에 따라 빈번한 원인 고려 (우측 표 참고)
- ③ 정신적 정서적 변화
- ④ 약물복용 : 경구피임제 등 호르몬제 사용 여부
- ⑤ 산과력
- ⑥ 하복부 동통 유무 통증 양상
- ⑦ 출혈성 혈액질환, 전신질환(부신 및 갑상선 질환, 만성신염, 간질환), 영양장애

★ 임신과 관련된 비정상 자궁출혈 빈발원인을 3가지 이상 서술 19

※연령층에 따른 자궁출혈의 대표원인

연령층	빈발원인		
신생아기	모성 에스트로겐의 소퇴 자연스럽게 사라짐		
유아기	생식기 외상, 질염, 이물질, 포도상 육종, 난소종양 질이 약간 외번되어 있어 감염에 취약함.		
사춘기	<u>시상하부 미숙</u> , 부적절한 황체기능, 정신적 문제, 영양적 문제 초경 후 무월경은 흔하여 괜찮은데 초경후 출혈량이 과다하면 치료 필수		
가임기	임신	자궁외임신 (spot bleeding, 점상 출혈이 나타남) 임신용모성 질환 예 '포상기태 유산, 잔류태반, 태반융종 환자에게 착상혈이 보이는 경우) 자궁내막은 자기제한적 특징이 있어 호르몬 작용이 점진적으로 일어나는데 한쪽만 갑자기 문제가 있는 경우에는 유산의 가능성이 높아 우선 유산가능성이 있음을 말해야 함.	
		무배란성	중추성
	중간적		영양, 부신/갑상샘, 기타 내분비 질환
	생식샘		종양-스테로이드 분비 낭포
	말초기관		자궁내막증식증 ←PCOS 오래되어 발생하기도 함)
	배란성	<u>구조적 병변이 가장 많음</u> → 종양성 감염(골반염증성질환), 점막하 근종 빈발월경 : 난포기 단축, 황체기 단축 불규칙출혈, 출혈성 혈액질환, 지속성 황체(Halban's disease)	
	의인성	항응고제, 자궁내 피임장치, 혈액투석	
폐경기	자궁내막암, 자궁목암, 용종		
² 폐경후기	외인성 에스트로겐, 자궁체부암, 난소암, 위축성 질염		

1 포상기태 : 초음파 상 포도송이같은 작은 낭포들이 관찰되며, 심한 임신오조증과 출혈 발생

2 ★폐경 후 출혈은 정상월경이 아니라, 암일 가능성이 매우 높으므로 반드시 면밀한 검사 필요

2) 신체검사

vital sign	환자의 Hb(헤모글로빈)수치를 반드시 확인
시진	- 영양상태 : 빈혈 비만 - 만성질환(쿠싱증후군) 내분비질환(특히 갑상선질환 염두)의 소견 - 다모증, 조모증 (PCOS 감별) - 혈액질환 소견 (반상출혈, 점상출혈)
내진	-

3) 선별검사 및 특수검사

- ★ 일반혈액검사 (CBC 헤모글로빈 WBC RBC 혈소판 수 빈혈)
- ★ B-hCG측정
- ★ 초음파검사: 자궁윤곽, 종양, 자궁내막 두께, 난소크기 (한창 bleeding 있을 때는 시행X)

- 혈중 LH, FSH, PRL, E2, T 측정 : PCOS 감별을 위한 루틴검사
- 부신 및 갑상선 기능 검사 잘 활용하지 않음
- 질 세포진 검사: 자궁경부암의 선별검사
- 자궁 내막 생검: 용종, 자궁 내막 이형성증
(PCOS 확실해서 자궁내막증식증이 있는 경우에만 소파 및 생검을 시행함)

*자궁내막증식증

- 어혈이 있는 상태로 화어지제 사용 후 조정시키는 약 사용
- 나이가 어느정도 있는 환자의 경우 소파를 권유
소파술의 장점
 - 1) 자궁내막 생검을 할 수 있고 시료를 풍부하게 확보 가능
 - 2) 격하축어탕같은 것을 쓸 필요 없이 주기조절로 치료할 수 있음.
 - 3) 지혈 목적(자궁내막증식증은 보통 기능적 자궁출혈을 같이 가지고 있는데 지혈이 가능함)
- 자궁내막증식증 환자는 초음파를 할 때 자궁내막의 두께를 재달라고 해야 함.

- 기초체온표, 황체기 중기 황체호르몬 측정: 의미 없음. 황체기결함에서만 그나마 의미가 있음.

- 진단적 복강경, 자궁경 검사, 자궁난관 조영술

5. 비정상 자궁출혈의 임상 유형

1) 배란성 비정상 자궁 출혈

배란을 동반한 이상 자궁출혈은 구조적 질환의 가능성을 먼저 고려해야 하며, 그 원인은 아래 표와 같음.

임신헌병증	후산물의 정체, 태반용종	
자궁외임신	-	
기질적 골반질환	(양성/악성) 신생물	자궁바닥의 근종, 육종, 암, 난관/난소암
	감염성 질환	* 결핵 , 골반염증성질환
	기타	* 자궁내막증 성교 후 출혈과 관련
¹ 배란기 출혈	-	
² 빈발 월경	난포기/황체기 단축	
³ 자궁내막의 부정박리	* 월경전 점형 , 연장된 월경	
지속성 황체	⁴ Halban's disease	
혈액 질환	* 특발성 혈소판감소성 자반증 , * 폰 빌리브란트병 , 백혈병	
의인성	항응고제, P유사 약물, 자궁내피임장치	

* 골반결핵 : 1차 병소인 폐에서 넘어옴. 골증조열 등 혈열 및 소모성 질환의 증상이 나타남. 출혈이 문제가 아니라 너무 아픈 것이 문제됨

* 자궁내막증 : 물리적으로 비정상 자궁출혈을 유발함

* 월경전 점형 : 자궁내막의 구조적 안정성이 떨어진다는 정황

* 특발성 혈소판감소성자반증 : 혈소판이 모자라거나 혈소판 파괴가 비정상적으로 빠른 것, 원인 불명이나 자가면역질환으로 추정됨. 혈소판 정상수치는 15~45만/ml인데, 5만 이하면 특발성 혈소판감소성 자반증에 해당하며, 부위를 가리지 않는 출혈이 발생함.

* 폰 빌리브란트병: 여성에게 생기는 혈우병 같은 것. 상염색체 유전 질환으로 여성에게도 나타남. 13가지 유형의 혈액 응고인자 중, 8번 응고인자의 문제가 생긴 것.

*근종: 장막하근종은 공간의 문제로 다른 기관을 압박하지 않음. 자궁내막쪽으로 자라는 경우 점막하근종이라고 하여 부정자궁출혈, 월경지연 등을 일으킬 수 있음.

(1) 배란기 출혈

≡ 배란 시 E의 일시적 감소로 인한 **E 소퇴성 출혈**

- 수 시간 내지 2일간의 미량 또는 점상 출혈

- [교과서] 환자를 안심시키고 치료할 필요가 없다. 교수님은 반대! 환자 안심이 잘 안됨.

(2) 빈발월경

- 월경 주기 21일 미만인 경우, 주로 시상하부의 조절 이상으로 인한 **무배란과**, 난포기/황체기 단축 등의 결과로 초래됨

- 대하 / 질 분비물 / 빈혈에 대한 확인 필요

(3) 부정 박리

- 황체기 결함에 나타나는 증상.

- E의 200pg/50h이 충분하지 못해서 P이 충분히 분비되지 못하여 발생.

- 월경 시 분비기 내막 탈락이 5일 이상 불규칙하게 지연되는 월경과다

- 암이 의심될 경우에만 생검

(4) Halban's disease

- 마찬가지로 황체기 결함에서 나타나는 현상

- 황체의 퇴화 지연으로 P의 분비가 월경 시작 후에도 계속되다 결국에는 충분한 양을 분비하지 못하는 결과로 인하여 예정 월경이 보통 몇 주 동안 늦어지며 불규칙하고 과도한 자궁 출혈을 유발

- 치료를 꼭 해야하는 것은 아님.

2) 무배란성 비정상 자궁출혈

- 초경 직후 시상하부 뇌하수체의 미숙 또는 폐경 전 난소 기능의 감퇴로 흔히 나타나나 가임기에서도 발생
- 무배란성 출혈은 연령에 따라 그 발생 원인에 차이가 있으므로 연령에 대한 고려가 중요

사춘기	- 무월경은 두고 볼 수 있지만 비정상 자궁출혈은 반드시 치료 - PCOS - 시상하부 미숙, 외음부병변, 외상 등
가임기	- 심인성 출혈 (주로 일시적) - PCOS (가장 多)
폐경기	- 암의 가능성 반드시 확인

3) 무배란성 비정상 자궁출혈의 치료

대부분 호르몬 요법, 경우에 따라서 자궁절제술

★봉루의 연령에 따른 원인 '03,11,19

※봉루의 연령별 발생원인의 차이

연령	근본 원인	구체적 사례 (선택사항)
사춘기 전 후	腎氣의 미성숙	① 선천성 - HPO축 미숙 ② PCOS ③ 정신/영양 문제
가임기	칠정상, 어혈	① 임신 관련 : 유산, 포상기태, 잔류태반 자궁외임신 ② 무배란성 : 갑상선 질환, PCOS, 자궁내막증식증 ③ 배란성 : 기질적 병변 (종양, 암, 감염) ex. 자궁근종
폐경기 전 후	腎氣의 쇠약	① 외인성 에스트로겐 (호르몬 치료로 인한 출혈) ② 위축성 질염 ③ 자궁경부암, 자궁내막암, 난소암

※ 기능성 자궁출혈의 호르몬 형태

★기능성 자궁출혈의 에스트로겐 파탄성 출혈에 대하여 설명하시오 '11, 12, 14, 18

★에스트로겐 소퇴성 출혈의 가장 많은 양상 / 파탄성 출혈에서 에스트로겐 농도차이에 따른 출혈의 양상을 쓰시오. '19

	에스트로겐	프로게스테론
¹ 소퇴	경간기, 배란기 출혈 E단독제재인 피임약 먹다가 나타나는 출혈도 여기에 속함 - 경간기: 규칙적인 월경과 월경 사이	³ 정상 월경
² 파탄	저농도의 지속적인 E자극 4고농도의 E자극	루漏의 형태 (장기간의 불규칙한 출혈) 붕崩의 형태 (일정기간 무월경 이후 갑작스런 대량 출혈) ①E에 대한 P의 비율이 지나치게 높은 경우 ② P제제를 쓸 경우

★ 가장 중요한 것은 E 파탄성 출혈 (= 기능성 자궁출혈 중 가장 빈발) 예 PCOS

→ 저농도의 E자극으로 출혈기간이 기고 불규칙한 경우와 (배란에는 충분치 않으나) 고농도의 E자극으로 일정기간 무월경이다 갑자기 대량출혈 발생하는 경우로 나뉨.

1 소퇴 : 분비가 꺾이면서 나타나는 출혈

2 파탄 : 대상 기관이 견디지 못해서 출혈 발생

3 정상적인 월경은 E의 적절한 작용 이후, P이 소퇴되면서 나타나는 P 소퇴성 출혈

4 고농도의 E자극 : 이때 고농도는 배란에는 충분하지 않은 정도임

※ 다낭성 난소 증후군 PCOS

- 미성숙 난포로 인해 E가 충분히 분비되지 않아 배란이 잘 되지 않고 월경을 하지 않음
- 배란하기에 충분하지 않지만, E가 조금씩은 분비가 되고 있는 상태이므로, 자궁내막은 계속 자극을 받아 증식하고 있음 → 무한대로 증식만 하지는 않으므로 언젠가는 무너지게 됨 (= E파탄성 출혈)

11절 봉루 p.77

1. 개술

(1) 정의

월경주기와 무관한 불규칙적 출혈

붕 붕 산무너질붕	대량의 지속적인 출혈
루 漏 물샘루	지속적인 소량의 출혈

(붕 ⇔ 루는 상호전화)

(2) 고전 기록

『경약전서-부인규-붕임경루불지』中

“붕루인 것은 경란이 극심한 것으로 봤다. 대개 경란하면 혹전혹후(或前或後)하고 루하면 불시에 망행한다. 루하면 임(淋)하고 임(淋)하면 붕하니 모두 혈병 때문이며 단지 심하고 심하지 않은가의 차이일 뿐이다”

(3) 임상

- 임상적으로 기능성 자궁출혈, 부정자궁출혈, 과다부정출혈 등을 참고할 수 있음

출혈량이 적을 때	자궁내막암, 자궁목의 미란, 용종, 배란기의 출혈, 경구피임제 복용, E과용/오용과 같은 의인성 요인을 염두
출혈량이 많으면서 갑자기 발생할 때	유산, 포상기태, 임신 용모암, 자궁외임신 등 임신 합병증을 감별 진단

- 환자의 연령에 따라 빈번한 원인이 다르므로 진단/치료에 있어 이에 대한 고려가 중요

- 치료의 목표 (뒤에 자세히)

- ① 급성 출혈의 지혈
- ② 재발의 방지와 정상 월경 주기의 회복
- ③ 수태 능력의 보존 (생식능력)

2. 병인병기

(1) 고전 기록

『황제내경』中

- 소문-음양별론 : “음허양박위지붕 (陰虛陽搏謂之崩)”
- 영추-백병시생편 : “양락상즉혈외일, 음락상즉혈내일 (陽傷則血外溢, 陰絡傷則血內溢)”

(2) 병인

★ 봉루의 병인병기 허, 열, 어의 상호전화 과정을 간단히 설명하시오. '19

- 봉루의 病源은 腎에 있고 대체로 虛, 熱, 瘀로 귀납할 수 있음
- ‘허+열+어’가 무조건 같이 오며, 상호전환함. 한 사람의 월경주기 안에서도 변증이 계속 바뀜.

허	체 → 어
	음허 → 열
열	모손 → 허
	열을 → 어
어	(어체 →) 순환장애 → 허/열

[★중요]

★ 봉루의 병리적 근본은 (腎)에 있고, 위치는 (衝任)에 있으며, 변화는 (氣血)에 있고, 표현은 자궁으로부터 월경 주기가 아닌 때에 출혈이 있는 것 '11, 19

[수업X 참고만]

예 자궁선근증 : 월경과다+월경통이 발생하는데, 기저귀+어르신 요실금팬티를 겹쳐 입어도 새는 정도의 양이 팔팔 쏟아짐. 이런 환자의 경우 월경 주기 안에서도 변증이 계속 바뀜.

- MCD1~3 : 혈열 (출혈팔팔)
- MCD 3~10 : 출혈로 인해 허가 극심해짐, 새로 신생혈관이 나타나므로 조금씩 어가 발달
- MCD15~ : 혈어

3. 명대 방약지의 봉루 치료 3단계

★ 봉루의 치료에 있어서 명대 방약지에서 제시한 3가지를 기술하고 그 의미와 현대의학적 의미에 대하여 기하시오. '03,11,14,18

[대원칙] 急則治其標, 緩則治其本 (표증인 출혈을 멈춘 후, 병의 근본이 되는 곳을 치료한다)에 따라 색류, 징원, 복구 등의 3가지 치법을 적용하여 치료

	현대 의미	내용
색류 塞流	급성 출혈의 지혈 [★강조]	원칙 [초기] 固氣攝血法 : 출혈량이 많은 시기에는 급히 지혈시켜 허탈에 빠지지 않도록 함 [후기] 출혈의 정도가 약해지면 固氣止血 清熱止血 消瘀止血 등의 지혈법과 다른 약물을 배오하여 치료 → 이후 출혈의 정도가 어느 정도 조절되면 징원, 복구 등의 방법을 사용 ★ 출혈증에 있어서 2가지 大綱을 한자로 쓰시오. ' 19 血見 (①) 血見 (②) ★ '지혈' 자체가 최우선 목표 이므로, 따로 변증하지 않음. → 지혈법이라 지혈만 시키면 되므로 변증을 할 필요가 없음. [혈병의 대강] 血見寒則休 血見黑則止(血見寒則休 血見黑則止) : 출혈에는 차가운 약을 초탄하여 지혈한다.
		처방 ★색류 처방은 초기 지혈에 몇 첩 단위로 3-5일 분만 쓰고 재내원 지도하고 출혈이 멈추면 바로 끊음. → '재'단위가 아닌 '첩'단위로 처방하는 이유로 너무 많이 쓰는 경우 오히려 여혈이 생기거나 나와야 할 피가 못나오고 니체가 생기게 됨.
		심회산 (十灰散) 그대로 사용X - 10가지 구성약물 : 대계 소계 측백엽 하엽 백모근 *천초근 대황 치자 *종려피 목단피를 초탄 - 차갑고 수렴시키는 약물들 *초탄하여 지혈, 혈이 멎쳐 어혈(니체)이 되지 않도록 활혈거어약(대계, 지유, 천초, 목단피 등)을 사용 - 출전 : 동의보감의 血門 (회: 재를 의미) - 초탄 : 새카맣게 태워서 재를 만든다는 의미. 위 약물들을 태운 후, 무즙/연근즙에 타서 먹으라고 복약지도 - 천초의 성분 중 rubiadin은 간/신/대장으로 향하는 발암의 시작/촉진 물질이므로 현재 사용금지 (천초를 대신할 수 있는 약물을 넣어 처방) - 종려, 측백엽: 수렴, 수습, 거뒤틀임 목적으로 사용, 주로 재출혈이 우려될 때 가감 (출혈이 진행될 때 많이 응용하는 편은 아님) - 삼칠근: 지혈약 중 초혹하지 않아도 되는 약이나 아직 정식 도입에는 한계가 있어 아쉬움이 있는 약
		가감석홍전 (加減惜紅煎) - 가장 많이 응용하는 약 중 하나 / 출전 : 청강의감 / 석홍전은 경약전서 부인규에 나오는 처방임 - 가감석홍전은 지유를 초혹하여 군약으로 사용함. (초탄까지는X) / 뒤에 나올 '월경과다-양성혈열'에도 가감석홍전이 나옴. - 차가운 약이 별로 없어 오로지 출혈을 막는 처방으로 특히 하부 출혈에 사용함.
징원 澄源	재발 방지, 정상 월경주기 회복	- 교(膠, 끈끈)한 약물을 사용하여 방금 멈춘 출혈의 재발을 방지함 (아교와 같은 약물은 초탄한 약물과는 다르게, 혈의 니체를 우려할 정도의 약성은 아님) - 근원을 맑게 한다는 의미로, 변증에 따른 치료 시행 - 적절한 조보간신, 보익심비 등을 통하여 혈의 근원을 자양하고, 혈실을 안정시켜서 월경이 규칙적으로 되게 함.
복구 復舊	수태 능력 보존	- 조리를 잘한다는 의미 (이때 전적으로 보혈에만 의존하는 것이 아니라, 그 병세를 살피서 알맞게 치료해야 함)

[교수님 첨언] 실제 임상에서는 복구까지 끌고가는 경우는 별로 없으나, 징원까지는 반드시 치료 해야함.

- 자궁선근증은 자궁 내 병변이 있되, 난소 기능은 정상이라 배란을 동반한 출혈이 과다한 상태임. 즉, 부정 출혈이 아닌 월경을 하되, 월경량이 많은 것이므로 '색류'로 보는 것은 적절치 않음.

4. 변증치료 ★★★★★ 해당 페이지 처방 설명하다가 끝남. 다음 시간에 수정해서 10주차에 다시 업로드할 예정

총 6개 : [허] 신기허, 비기허, 간신후손 [열] 음허혈열, 간울혈열 [어] 혈어

변증	출혈 특징 (출혈의 색과 질 위주로 체크)	동반 증상	치법 (언급X)	처방
¹ 신기허 '17	월경주기 불규칙하며 출혈량이 많거나 소량의 출혈이 지속 간혹 몇 달간 월경이 없다 갑자기 많은 양이 있으며 지혈이 되지 않기도 함 출혈은 옅은 붉은 색/어둡고 묽은 양상	얼굴색이 어두움(면암), 허리와 무릎이 시림(요슬산연), 소변이 맑고 양이 많음(소변청장), 설담능, 설태백운, 맥침약	보신고충 지혈조경	통맥대생환, 생맥이지지혈탕
★ ² 간신후손 '03,05,17	월경주기 불규칙하며 적은 양이 그치지 않거나 단번에 다량의 출혈 수개월간 월경이 없다가 갑자기 쏟아지기도 함. 어두운 검은색 출혈, 광택이 없고, 묽거나 덩어리가 있음.	머리가 어지러움(두훈), 귀가 울림(이명), 눈앞에 아지랑이가 펴(목현), 안색에 윤기가 없음(면색무화), 모발이 많이 빠짐(모발탈락), 설암담, 태박/박황, 맥세/세삭	자보간신 조고충임	좌귀환(음허) ⁴ 귀신환(양허)
³ 음허혈열 '17	하혈이 갑자기 진행되면서 양이 많거나 소량출혈 지속 선홍색의 걸쭉한 출혈	머리가 어지러움(두훈), 귀가 울림(이명), 속이 답답함(번조), 조열이 있음, 설홍, 태박황, 맥세삭	자음청열 량혈지혈	⁵ 상하상자탕 보음전
★★비기허 '12,13,14,17	출혈이 갑자기 많음, 색이 연하고 질이 묽음	피곤하고 숨이 가쁨(신피기단), 안색 윤기없이 힘(면색창백), 심계, 설담, 태박백, 맥완무력	보비익기 양혈고충	★[강조] ⁶ 고본지붕탕+ ⁷ 거원전
★간울혈열 '15,17	하혈이 갑자기 진행되면서 양이 많거나 출혈량이 적으면서 계속됨. 혈색심홍, 질은 끈끈, 혈괴가 있음	양쪽 아랫배가 그득하며 아픔, 옆구리&유방이 팽창+아픔 (소복,협늑,유방창통) 속이 답답하고 불편함, 설홍, 태황, 맥현삭	청간개울 지혈조충	청열고경탕 ⁸ 자수청간음
혈어 '17	하혈이 갑자기 진행되면서 양이 많거나, 출혈량이 적으며 계속됨. 혹은 월경이 없다가 갑자기 많은 양이 쏟아지고 적은 양의 출혈이 계속되기도 함. 출혈색은 암하고 질은 조하며 덩어리가 있음.	소복통/창통이 있음. 설암홍, 주변에 어반이 있음, 태박백, 맥침삽/침현	활혈화어 지혈고충	사물탕+ ⁹ 실소산, 개울사물탕

- ① 신기허 ; 보통 허증은 출혈량이 많은 편은 아님
- ② 간신후손 : 신기허에 간장혈 기능 실조된 상태
- ③ 음허혈열 : 폐경기 즈음에 호르몬 난조로 인해 이러한 변증을 보임.
- ④ 귀신환 : 신기를 평보함
- ⑤ 상하상자탕 : 석실비록에 나온 (상하상자탕, 보음전 : 주로 보음지제가 들어감)
- ⑥ 고본지붕탕 : 이름만 보면 지붕시킨다고 하니, 지혈시키는 색류 처방 같으나, **색류 처방 아님!**
(구성 : 숙지황 20g, 백출 20g, 황기 6g, 당귀 10g, 흑강 4g, 인삼 6g) = 십전대보탕 변방
십전대보탕에서 서근활락시키면 안되므로 백작약 빼고 활혈시키면 안되니 천궁을 제외, 온경시
키는 육계를 제외, 흑강을 넣음. 결론: 십전대보탕 합 보중익기탕을 응용한 변방이다.
- ⑦ 거원전 : 경약선생의 보중익기탕을 간략하게 만든 처방임. 중기하합되면 대맥이 같이 풀리면서
아래로 흘러 내려가는 것을 치료. (원래는 대맥이 허리춤에서 딱 붙잡아두고 있어야 함)

- ⑧ 자수청간음 : 시호 치자 목단피 들어가서 소간+양혈 작용
- ⑨ 실소산 : 포황+오령지로 구성됨. 출혈이 멈춘 후 사용하는 처방으로, 원래는 산후 아침통과 훗
배앓이에 사용함.
- 산후 아침통 : 태아가 머리를 배고 있는 자리가 아픈 것으로, 아두가 아래를 향하고 있기
때문에 나타나는 하복통
- 훗배앓이 : 출산 후 배 전체가 아픈 것. 경산부에게 종종 나타남. 초산부는 한번도
늘어난적이 없는 자궁이라 출산 후 자궁이 다시 수축하는데 별 문제가 없는데, 경산부는
한번 불었던 풍선과 같아서 훨씬 더 많은 수축력이 필요함. 이 수축력에 의해 훗배앓이가
나타남.
- 오령지 = 날다람쥐의 말린 똥으로, 부인과의 요약. 서근활락 + 활혈거어 작용에 자궁수축도
잘 하게 하고, 지통 작용도 좋음. 특히, 월경에 의한 자궁수축에 의한 통증에 안 빠짐.

- 3) 瘀證에 속한 崩漏
- 相應하는 方劑 + 理氣化瘀(香附子炭 玄胡索炭)
 - 相應하는 方劑 + 祛寒行瘀(乾薑炭 桂心炭)
 - 相應하는 方劑 + 活血去瘀(桃仁炭 乾漆炭)
 - 相應하는 方劑 + 行血止血(茜草炭 蒲黃炭)
- 炭方 뜻에 있어서도 병인에 따라 治方을 구성한다는 원칙은 변함이 없다.
- 《婦人良方大全》琥珀散: 赤芍藥炭 荷葉炭 血餘炭 當歸炭 棕櫚炭 乾漆炭
- 《十藥神書》十炭散: 大薊炭 小薊炭 側柏炭 荷葉炭 棕櫚炭 茜草炭 山梔子炭 茅根炭 大黃炭 牡丹皮炭

② 봉루에 탄약을 이용함은 약물의 부작용을 없애고 이점을 이용하는데 그 목적이 있다.

- 약물의 편성을 조정하는데 炭하는 것이 효과를 가진다.

- ex) 滋補藥物 - 炭 → 보하면서도 泥滯되지 않음
- 化瘀藥物 - 炭 → 去瘀하면서도 傷血하지 않음
- 寒涼藥物 - 炭 → 清열하면서도 傷胃하지 않고 凝血을 방지
- 辛溫藥物 - 炭 → 溫經止血하면서도 動血하지 않음
- 봉루 치료에 적절한 치료효과를 기대할 수 있음.

③ "崩漏留瘀"와 炭藥

- 崩漏의 치료가 적절하지 못하여 瘀血이 형성된 것을 말함. 많은 의가들이 봉루의 치료에 탄약을 활용하는 경우 留瘀됨에 주의함.
- 留瘀됨에는 지혈고삼하는 탄약뿐만 아니라 병인과 병기를 고려하여야 함.
 - 봉루의 虛 → 과다한 補 → 氣機를 응체시켜 瘀滯를 이룸.
 - 봉루의 熱 → 과다한 寒涼 → 血脈을 응체시켜 瘀滯를 이룸.